

ホルモン療法(内分泌療法):薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 ホルモン療法の薬薬連携 — 年単位の服薬継続を支える

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
① 閉経状況・受容体・治療期間とレジメンの整合性の確認	治療目的・予定期間 (5年・10年など)	① 年単位の服薬継続の支援(残薬・自己中断の確認)
② LH-RH製剤など注射の投与スケジュール管理	骨密度・骨の薬 (AI・ADT)	② ほてり・関節痛など継続の妨げになる症状の聴取と対処
③ 骨密度検査・骨を守る薬の導入の提案	自己中断の理由 (関節痛・ほてり)	③ アビラテロンの空腹時服用・プレドニゾン併用の確認
④ アビラテロン開始時の肝機能・カリウムの確認	カリウム・肝機能 (アビラテロン)	④ 他院の抗うつ薬・抗凝固薬・スタチン等の相互作用確認
⑤ お薬手帳への治療目的・予定期間の記載		⑤ 骨の健康(カルシウム・歯科受診)の指導と情報提供

2 主な薬剤の服用方法と薬局での確認ポイント

タモキシフェン	指示どおり 1日1回、5～10年	✓ ほてり ✓ 静脈血栓塞栓症 ✓ 子宮内膜の変化 ✓ 不正性器出血・片足の腫れ
アロマトラーゼ阻害薬	指示どおり 1日1回、5年～	✓ 関節痛・こわばり ✓ 骨密度低下 ✓ 骨密度検査・骨粗鬆症治療薬 ✓ 関節痛での自己中断
LH-RHアゴニスト	指示どおり 皮下注射(1・3・6か月ごとの製剤)	✓ ほてり ✓ 骨密度低下 ✓ 開始初期のフレア ✓ 次回の注射日
アビラテロン	空腹時 1日1回 空腹時、プレドニゾンと併用	✓ 低カリウム血症 ✓ 高血圧 ✓ 浮腫 ✓ 肝機能障害
エンザルタミド・アパルタミド	指示どおり 1日1回	✓ 疲労 ✓ 転倒・骨折 ✓ 皮疹(アパルタミド) ✓ 他院処方への影響(酵素誘導)
ダロルタミド	食後 1日2回 食後	✓ 疲労(比較的少ない) ✓ 食後服用 ✓ ロスバスタチンとの併用

● 空腹時 ● 食後 ● 食事に関係なく ● 指示どおり 服用時点は交付時に具体的な時刻で説明

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意 添付文書 併用注意	タモキシフェン CYP2D6阻害(活性化↓)	処方薬 パロキセチン等の強いCYP2D6阻害薬	活性代謝物↓ → 効果減弱のおそれ	他院の抗うつ薬を確認し、代替を処方医と相談
注意 添付文書 併用注意	タモキシフェン 抗凝血作用の増強	処方薬 ワルファリン	INR↑ → 出血	INR測定の前定を確認
注意 添付文書 併用注意	エンザルタミド・アパルタミド 代謝酵素の誘導	処方薬 ワルファリン・一部のDOAC・睡眠薬等	併用薬の濃度↓ → 効果減弱	他院処方を確認し、効果の低下を処方医と共有
注意 添付文書 併用注意	ダロルタミド BCRP等の阻害	処方薬 ロスバスタチン	ロスバスタチン濃度↑	スタチンの用量と筋肉痛を確認
注意 添付文書 用法・用量	アビラテロン 食事で吸収が増加	生活習慣 食事と一緒に服用	血中濃度が大きく上昇 → 副作用↑	食事の1時間前～食後2時間を避けて服用
注意 添付文書 併用注意	内分泌療法全般 作用の拮抗	処方薬 エストロゲン製剤(ホルモン補充療法等)	治療効果の減弱	婦人科など他院の処方を確認

4 服薬指導タイムライン(声かけ例)

① 治療開始時	② 1～3か月	③ 半年～1年	④ 年単位
“この治療は年単位で続けることで再発を防ぎます。飲み忘れを防ぐ工夫を一緒に考えましょう”	“ほてりや関節の痛みはありませんか。続けにくいと感じたら教えてください”	“骨密度の検査は受けましたか。カルシウムやビタミンDをとり、体を動かしましょう”	“ここまで続けられていますね。気になる症状は変わりありませんか”
✓ 薬局で確認 治療目的・予定期間、閉経状況、他院の抗うつ薬・抗凝固薬	✓ 薬局で確認 副作用と対処法、注射の予定、血圧・カリウム(アビラテロン)	✓ 薬局で確認 骨密度検査・骨粗鬆症治療薬、歯科受診(骨の薬を使う場合)	✓ 薬局で確認 残薬と服薬継続、不正性器出血(タモキシフェン)
△ ここに注意 アビラテロンは空腹時の服用を具体的に説明	△ ここに注意 片足の腫れ・急な息切れは血栓症を疑い至急受診	△ ここに注意 転倒・骨折のリスクを評価	△ ここに注意 自己中断があれば理由を聞き処方医と共有